

מתי לחשוד ב־PSVT בילדים

- + לאחר תשאול רלוונטי של המטופל וסביבתו (אירועים קודמים, מום לב מולד, הופעה חדה).
- + קצב לב גבוה מ־220 בדקה בתינוקות, וגבוה מ־180 בדקה בילדים.
- + גלי P חסרים או אבנומליים.
- + מרווח R-R קבוע.

1 גירוי וגאלי

- + בתינוקות וילדים קטנים (עד גיל 6) יבוצע באמצעות הנחת שקית קרח עטופה במגבת על הפנים.
- + בילדים בוגרים יבוצע באמצעות תמרון Valsalva או באמצעות נשיפה מאומצת לתוך קשית.
- + אפשר לבצע עיסוי קרוטי.

2 אדנוזין

- + מנה ראשונה – 0.1 mg/kg.
- + מנה מקסימלית – 6 mg.
- + מנה שנייה (לפי הצורך) – 0.2 mg/kg.
- + מנה מקסימלית – 12 mg.
- + מתן ב־PUSH מהיר ולאחריו הזרקה מיידית של 5 ml סליין.
- + יש להמתין 1-2 דקות בין המנות.
- + אין לתת למטופל המוכר כסובל מפרה־אקסיטציה (WPW).
- + יש להיוועץ ברופא במוקד הרפואי טרם מתן לילדים הסובלים מאסתמה קשה.

...



3 אמידורן

- + מינון – 5 mg/kg במשך 20 דקות. בזמן הפינוי לבית החולים.
- + מינון מקסימלי – 300 mg .
- + אין לתת למטופל הידוע כרגיש ליוז.

4 היפוך חשמלי מסונכרן

- + שקול מתן סדציה לפי הוראות פרוטוקול
- + טכיקרדיה בתינוקות ובילדים.
- + בצע עד שני ניסיונות רצופים.
- + אנרגיה התחלתית – $0.5-1 \text{ J/kg}$.
- + אנרגיה מקסימלית – 2 J/kg .